



PROTOCOLO DE RASPADO Y ALISADO RADICULAR POR SEXANTES

Tratamiento no quirúrgico desinflamatorio

Clínica Universitaria de Odontología

1. OBJETIVO:

Cambiar el ambiente y eliminar los patógenos mediante tratamiento mecánico y químico.

Mecánico: desbridamiento radicular con curetas

- Remover la placa
- Eliminar cálculo subgingival y endotoxinas adheridas a la superficie radicular para reducir la inflamación gingival y detener la progresión de la periodontitis.

Químico: antisépticos y antibióticos tópicos o sistémicos si se precisa

2. INDICACIONES

- Bolsas periodontales ≥ 4 mm con o sin sangrado.
- Evidencia de pérdida ósea o movilidad dental leve-moderada.
- Presencia de cálculo subgingival no accesible mediante profilaxis.

3. TRATAMIENTO PERIODONTAL TRADICIONAL

1. Desbridamiento inicial no quirúrgico: profilaxis dental supragingival, raspado y alisado radicular.
2. Reevaluación y valorar terapia de mantenimiento periodontal o necesidad de tratamiento posterior, generalmente quirúrgico.

4. TRATAMIENTO ETIOLÓGICO

Abordar todos aquellos factores que emporen o dificulten la buena evolución de la nueva inserción o favorezcan el acúmulo de patógenos, impidiendo la correcta HO por parte del paciente:

- Márgenes de las restauraciones
- Caries
- Reabsorciones radiculares
- Prótesis mal ajustadas
- Ortodoncia
- Malformaciones
- Hábitos: tabaco, cepillado defectuoso, respiradores bucales.

5. CONTROL MECÁNICO DE LA PLACA BACTERIANA

- Técnicas de cepillado
- Seda dental cuando existe papila
- Cepillos interproximales si no existe papila

La biopelícula se adhiere a las 12 horas del cepillado, por lo que el control de placa debe ser exhaustivo y extensible en el tiempo.

Tto profesional subgingival + Cuidado minucioso del paciente



Control de la EP

6. TRATAMIENTO PERIODONTAL BÁSICO

Raspado: eliminación de la placa dental y cálculos adheridos a la **pared radicular** supra y subgingival.

Alisado: eliminación del **cemento** de la pared radicular expuesto a una bolsa periodontal.

Curetaje: eliminación del **epitelio** de la pared interna de la bolsa periodontal

Raspado + alisado + curetaje → se hace sistemáticamente en el mismo procedimiento terapéutico.

Pulido: eliminación de la película adherida a la superficie dentaria.

Nota: Esta fase desinflamatoria es el tratamiento definitivo para la gingivitis y periodontitis ligera (estadios I y II), y el tratamiento de preparación prequirúrgico para periodontitis moderadas y avanzadas (estadios III y IV).

7. INSTRUMENTAL NECESARIO

A. **Curetas Gracey Hu-Friedy**

- a. Cureta 5/6
- b. Cureta 7/8
- c. Cureta 11/12
- d. Cureta 13/14

B. Ultrasonido con puntas adecuadas.

C. Kit exploración con espejo y sonda periodontal.

D. Jeringa y anestesia local (infiltrativa o troncular según el caso).

E. Fresas de pulir tipo Perioaset.

F. Jeringa de irrigación con clorhexidina (Perioaid) o Betadine + agua oxigenada.



8. PROCEDIMIENTO PASO A PASO

A. Anestesia

- Anestesia por cuadrante/sextante o zona a tratar si hay sensibilidad o bolsas profundas.

B. Ultrasonido

- Uso inicial para desorganizar cálculo más voluminoso.
- Refrigeración adecuada para evitar trauma térmico.
- Movimiento lateral o coronal-apical suave.

C. Raspado con curetas

- Adaptar la hoja al diente con un ángulo de 70°–80°.
- Presión controlada, movimientos cortos y solapados.
- Cubrir toda la raíz hasta fondo de bolsa.
- Revisar presencia de cálculo residual.

D. Alisado radicular

- Pulir la superficie con movimientos suaves para dejar una raíz lisa y descontaminada, utilizando fresas Periojet.

E. Reevaluación táctica

- Exploración con sonda periodontal, confirmando que la raíz esté libre de cálculo y lisa.
- Irrigar con jeringa CHX o Betadine + agua oxigenada.